

УДК:618.19-006:616.89-089

Ж.Ф. Айуп, Г.А. Рысбаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Психолого-социальная реабилитация после мастэктомии при раке молочной железы

Аннотация. Статья посвящена процессам реабилитации у женщин после мастэктомии при раке молочной железы. Рассматриваются виды реабилитации, их важность и значимость для восстановления здоровья, а также возвращению и адаптации онкобольного в социальную среду.

Ключевые слова: реабилитация, мастэктомия, психосоциальная поддержка, эмоциональное равновесие, оптимизация телесного функционирования, консультирование с выбором профессии, социальная адаптация, социально-бытовая реабилитация; превентивный тип, укрепляющий тип, поддерживающий тип, паллиативный тип реабилитации.

Актуальность. Медицинская помощь в индустриальных странах с высокоразвитыми системами здравоохранения подразделяется на профилактические, лечебные и реабилитационные услуги.

Позднее понятие «реабилитации» с его скорее юридического значения поменялось на медицинское социально-этическое. В секторе здравоохранения современных индустриальных стран произошли сложные и взаимообусловленные изменения. Возросло значение профилактики и реабилитации. Наряду с диагностикой и терапией органических болезней получили признание психосоматика и учет факторов риска, вытекающих из взаимосвязанного воздействия общества, рабочей и окружающей среды на здоровье и болезнь человека [2]

В связи с этим Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/ в 1990 г. была разработана и провозглашена всеобъемлющая концепция охраны и укрепления здоровья, которая учитывается все в большей мере в национальной политике здравоохранения индустриальных стран. Принципы охраны и укрепления здоровья, содержащиеся в концепции, имеют значение как для профилактики, так и для реабилитации, как системе государственных, социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий направленных на эффективное и раннее возвращении больных и инвалидов в общество и к общественно полезному труду.

В 1972 г. Национальный институт рака (США) провел конференцию по вопросам развития реабилитации в онкологии, на которой были утверждены основные направления, или уровни, в реабилитации онкологических больных: психосоциальная поддержка, эмоциональное равновесие, оптимизация телесного функционирования, консультирование с выбором профессии, социальная адаптация и социально-бытовая реабилитация. На то время реабилитацию определяют как процесс, который позволяет онкологическому больному достигать максимального телесного, психологического и профессионального функцио-

нирования с одновременным ограничением распространения болезни, эффективным лечением, профилактикой осложнений и метастазирования опухоли. [2]

В Казахстане онкологические пациенты следуют единой программе реабилитации. Одну из частей реабилитации составляет психосоциальная помощь. Реабилитация является важной составляющей частью проводимого лечения.

Существуют различные варианты клинического течения злокачественного заболевания. Группа с благоприятным прогнозом включает в себя наблюдения с 1-2 стадией опухоли, которые, как известно, имеют реальный шанс излечения от заболевания. Причем эта закономерность прослеживается для большинства локализаций поражения: легкое, желудок, шейка матки, молочная железа, гортань и т. д. И при символах T1-2NoMo 5-ти летняя выживаемость этой группы больных достигает от 60 до 90%. Большинству пациентов при этом возможно проведение функционально щадящего и органосохранного лечения с применением методик хирургической резекции пораженного органа с сохранением функциональной части, нередко с одномоментной реконструкцией [3]

J. Dietz (1981), рассматривая процесс предоставления реабилитации онкологическим больным, выделила четыре типа реабилитации в онкологии – превентивный, укрепляющий, поддерживающий и паллиативный.

- Превентивный тип реабилитации – реабилитация, которая направлена на профилактику инвалидности через образование пациента, психологическое консультирование, исследование функционального и физического состояния организма перед началом лечения.
- Укрепляющий тип реабилитации – комплекс средств, которые направлены на возвращение пациентов к прежнему образу жизни, профессиональной деятельности, физического, психологического и социального состояния.
- Поддерживающий тип реабилитации – комплекс средств, направленных на образование пациента, с целью предоставления ему возможностей приспособиться к инвалидности, которая возникла, и минимизировать осложнения от болезни, которая продолжается.
- Паллиативный тип реабилитации – реабилитационные мероприятия, которые проводятся с больными, у которых наблюдается пролонгация болезни. Мероприятия направлены на ликвидацию осложнений, обеспечение комфортом и поддержку.

Цель паллиативной реабилитации заключается в создании комфортных условий существования (контролирование боли и

ее обезболивание, профилактика контрактур и язв, психологическая поддержка пациента и его семьи) в период прогрессирования и генерализации злокачественной опухоли, что может обусловить неблагоприятный прогноз жизни.

Следует отметить, что не существует четких границ в применении того или иного типа реабилитации в каждом конкретном случае, поскольку развитие опухолевого процесса имеет индивидуальные особенности. Например, прогрессирование опухолевого процесса после радикального лечения влияет на тип реабилитации – переход с превентивного на паллиативный. А реконструктивно-пластическая операция с восстановлением дефекта тканей, например лица и верхней челюсти, позволяет провести пациенту превентивную реабилитацию вместо поддерживающей.[3]

Прогноз заболевания приобретает более серьезный характер в группе пациентов с III стадией опухоли. Возможность проведения функционально щадящего лечения при подобной распространенности процесса весьма сужена. Чаще для адекватного удаления опухоли и лимфоузлов требуется выполнение инвалидизирующей операции в комбинации с лучевой терапией и химиотерапией, тем самым причиняя выраженный анатомофункциональный дефект. Например, гастрэктомия, пневноэктомия, мастэктомия. [5]

Онкобольные испытывают страх, тревогу, стресс, во многих случаях депрессию и другие психологические проблемы. Эти проблемы не только снижают настроение больного, но и отнимают у него необходимую энергию и силу, что, в конечном итоге отражается на качестве хода лечения. В таком состоянии человеку для достижения благоприятного исхода заболевания необходима психологическая поддержка и применение психотерапии. [4]

Реабилитацию необходимо проводить согласно индивидуальным программам с учетом возраста, пола, вида онкологического заболевания, его стадии, метастазирования и др. Реабилитация проводится представителями многих специальностей: врачами, психологами, социологами, юристами, протезистами, инструкторами ЛФК, работниками органов социального обеспечения и др., так как максимальное восстановление трудоспособности требует полной физической, психологической, социальной и профессиональной адаптаций.[3]

Некоторые мероприятия осуществляемые реабилитацией связанные с лечебной физкультурой, физической, психологической адаптацией:

1. Комплекс восстановительной терапии, включающей лечебную физкультуру, в том числе и медикаментозное лечение, а возможно и гидротерапию, позволит больным после мастэктомии скорее восстановить функцию верхней конечности, уменьшить число поздних послеоперационных осложнений (контрактуры плечевого сустава и лимфостаз).
2. Гидрокинезиотерапия является новым направлением ЛФК и применяется для восстановления функций мускулов и суставов. Лечебное действие упражнений дополняется восстановительными свойствами морской воды.



3. Фотодинамическая терапия применяется для уничтожения оставшихся в организме патологически измененных клеток путем воздействия света и активного кислорода в комплексе. Кроме того, при реабилитации онкобольных показана общая кислородная терапия, позволяющая снизить, а в дальнейшем и полностью ликвидировать дыхательную недостаточность. Она также улучшает репаративные процессы в организме.



4. Система «Вита-Лайф» предназначена для выполнения лечебных и реабилитационно-релаксирующих процедур на основе:
 - Низкоинтенсивной резонансной магнитофото и звуковой терапии и физиологической электростимуляции.
 - Синглетно-кислородных и аромапроцедур.



5. Система «Купава 2». Предназначена для выполнения гидро-массажных лечебных и релакс процедур в вариантах:

1. Душ Виши и световодной душ.
2. Пенный массаж.
3. Синглетно-кислородные, углекислотные и озоновые ванны.



Для достижения целей реабилитации онкологического больного применяются специальные методы или компоненты реабилитации.

Следует подчеркнуть, что в современной клинической онкологии понятие лечение и реабилитация неразрывны, обеспечивая преемственность и последовательность этапов общего лечения. Лечебный компонент является основополагающим, определяющим как результат лечения так и реабилитации.[5]



Приоритетным направлением современной клинической онкологии является функционально щадящее и органосохранное лечение злокачественных опухолей основных локализаций. Одним из основных принципов функционально-щадящего лечения является совмещение этапов хирургического удаления опухоли и хирургической реабилитации. Этот принцип в настоящее время применим для больных I-II ст. и большей части III ст. благодаря внедрению в онкологию реконструктивно-пластического компонента восстановления пораженного органа. Напри-

мер, резекция и пластика пищевода, гортани, трахеи, радикальная резекция молочной железы с реконструкцией и т. д. [3]

Реконструктивно-пластический компонент хирургической реабилитации онкологических больных включает в себя комплекс методов современной реконструктивно-пластической хирургии, позволяющих в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью восстановить функцию и внешний вид органа, его эстетические параметры, что особенно важно для лица, молочных желез, конечностей. Наиболее часто применяются методы функциональной резекции, пластики местнопеременными лоскутами, микрохирургической аутоотрансплантации тканей, а также имплантации искусственных тканей (рисунок 1).

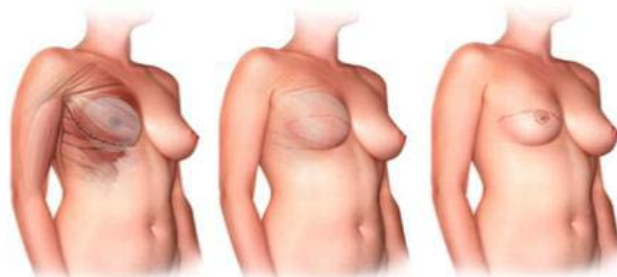


Рисунок 1 - Реконструкция груди после мастэктомии с использованием имплантата (экспандер)

Метод пластики местнопеременными лоскутами применяется для восстановления небольшого по площади дефекта органа или ткани с использованием однородных тканей, расположенных вблизи дефекта. Например, при радикальной резекции молочной железы из ее оставшейся части путем мобилизации тканей и их объемного перемещения реконструируется форма органа. Иссечение опухоли кожи или мягких тканей без причинения функционального дефекта завершается мобилизацией краев раны с выкраиванием из них треугольных или трапецевидных лоскутов и укрытием раневого дефекта (рисунок 2)

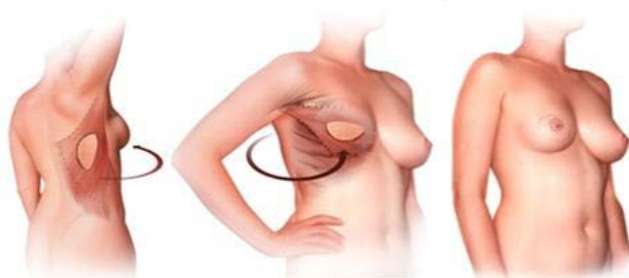


Рисунок 2 - Реконструкция груди после мастэктомии с использованием лоскута кожи и мышц пациентки (из широчайшей мышцы спины и из прямой мышцы живота)

Метод микрохирургической аутоотрансплантации тканей основан на анатомических исследованиях человеческого тела, которые показали, что некоторые участки нашего организма имеют так называемое изолированное кровоснабжение, что позволяет выделить один или два сосуда снабжающих кровью в необходимом и достаточном количестве избранный участок органа или ткани. Следовательно, тканевой трансплантат может быть перемещен на выделенной сосудистой ножке или отсечен и перенесен на зону дефекта с немедленным восстановлением кровообращения путем подключения сосудистой ножки лоскута к источнику кровоснабжения в зоне дефекта. Именно послед-

ний вариант порождает богатое разнообразие пластического материала, который обладает высокой живоспособностью благодаря технологии микрохирургического соединения питающих сосудов и нервов. Свободный подбор пластического материала в полном соответствии с тканями дефекта, будь то кожа, клетчатка, фасция, мышца, кость и т. д., позволяет выполнять сложную реконструкцию органов по площади, объему, функции. [5]

Перечисленные компоненты применяются на последовательных этапах реабилитации:

1. Подготовительный /предлечебный/. На этом этапе основное внимание следует уделять психике больного. Под воздействием мощной стрессовой ситуации у пациента, направленного в онкологическую клинику, возникают острые психогенные реакции, среди которых преобладает депрессивный синдром. Психологически в беседах врача необходимо больного информировать об успехах лечения онкозаболеваний, возможностях органосохранного подхода. По показаниям следует применять седативные препараты. Этот этап непосредственно связан со специальной медикаментозной и немедикаментозной подготовкой, направленной на лучшую переносимость операции и других лечебных мероприятий.
2. Лечебный /основной/. Он включает в себя операцию по удалению опухоли и сохранению или пластическому восстановлению анатомических основ функции оперированного органа. Это также может быть курс специальной лучевой терапии на опухоль с сохранением соседних тканей.
3. Ранний восстановительный /послеоперационный/. Важной задачей этого этапа является его проведение в естественные биологические сроки до 2-3 недель, без срывов. Целесообразно применять апробированные в онкологии методы улучшения регенерации: низкоэнергетические лазеры, КВЧ-установки. В конце этапа необходимо начинать специальную ЛФК, в т. ч. на тренажерах.
4. Поздний восстановительный. Этап является непосредственным продолжением предыдущего. Продолжается ЛФК, терапия по регуляции функции оперированного органа. Например, набор ферментных препаратов пищеварительного тракта, временно заменяющих их недостаток в организме при резекции желудка, поджелудочной железы и т. д. Параллельно начинают проведение специальной противоопухолевой химио- и лучевой терапии. В связи этим реабилитационные мероприятия планируются с учетом лечебных, чтобы исключить их взаимное подавление. Этап занимает от 1 до 6 мес., который определяется индивидуальным планом лечения. За это время можно решать вопросы эстетической реабилитации, включая корригирующие операции, шлифовку рубцов и т. д.
5. Социальный. На этом этапе первостепенное значение приобретает психический статус онкологического больного, его социально-трудовая ориентация. Как показывает практика, на этом этапе жизни пациенты очень нуждаются в моральной и терапевтической поддержке по нормализации психического статуса и гомеостаза.

Так как процесс лечения и реабилитации онкологических больных занимает в среднем от 3 до 6 мес. очень важной ста-

новится функция врачебно-трудовой экспертизы, особенно на последних этапах лечения. [3]

У женщин, перенесших мастэктомию, часто встречаются отсроченные эмоциональные переживания. Больные, пройдя ознакомление с диагнозом, оперативные вмешательства и последующие химио- и радиотерапию, держатся достаточно стойко, не впадая в депрессивные состояния. Но после полученного лечения, интенсивного общения с врачами, оценивая прошедшие события как завершившиеся, неожиданно для себя начинают испытывать непонятную сильную тревогу, волнения, отмечают повышенную слезливость, неконтролируемые вспышки гнева и раздражения. Это происходит от того, что пациенты, узнав о диагнозе, мобилизируют все свои силы на борьбу с болезнью, откладывая душевные переживания «на потом». И когда длительное лечение подходит к концу, эмоции, долгое время сдерживаемые, неконтролируемо прорываются наружу.

«Исследования, проведенные в США, Европе, России, показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями, которые после выписки из клиники начинают посещать группы поддержки, проходят курс психотерапии или психологических консультаций, не только способны улучшить качество жизни при болезни, но и меньше подвержены ее рецидивам. Психологическая коррекция не противопоставляется основному противоопухолевому лечению, а, наоборот, потенцирует его воздействие» [1].

Реабилитация онкологических больных проводится в отделениях восстановительного лечения онкологических диспансеров или в центрах (больницах) восстановительного лечения общего профиля. В отделении проводятся курсы поддерживающей и общеукрепляющей терапии, коррекция анатомо-функциональных нарушений, психотерапия, восстановление трудоспособности больных.

В структуру отделения восстановительного лечения в онкологическом стационаре входит 8 групп:

1. Клиническая группа. В ее задачи входит разработка и внедрение в клиническую практику новых методов хирургического восстановительного лечения, включая пластические хирургические операции.
2. Гастроэнтерологическая группа осуществляет обследование и комплексное восстановительное лечение больных, страдающих постгастрорезекционным синдромом.
3. Проктоурологическая группа выполняет комплексное восстановительное лечение больных после операций на прямой и толстой кишках, а также урологических больных с различными послеоперационными осложнениями.
4. Группа сложного протезирования онкологических больных. Данным пациентам выполняется сложное челюстно-лицевое протезирование по поводу онкологических заболеваний головы и шеи. А также протезирование верхних и нижних конечностей.
5. Группа восстановления звучной речи проводит курсы логовосстановительной терапии у пациентов, перенесших операции на гортани, челюстях, языке и т. д.
6. Психотерапевтическая группа занимается коррекцией психологических проблем на всех этапах лечения пациентов.

7. Группа лечебной физкультуры и физиотерапии осуществляет восстановление нарушенных функций движения, например, разработка контрактуры суставов.
8. Группа трудотерапии осуществляет процесс возвращения больного к труду [2].

Психологическое сопровождение женщин после мастэктомии при раке молочной железы

У женщин, перенесших мастэктомию, часто встречаются отсроченные эмоциональные переживания. Больные, пройдя ознакомление с диагнозом, оперативные вмешательства и последующие химио- и радиотерапию, держатся достаточно стойко, не впадая в депрессивные состояния. Но после полученного лечения, интенсивного общения с врачами, оценивая прошедшие события как завершившиеся, неожиданно для себя начинают испытывать непонятную сильную тревогу, волнения, отмечают повышенную слезливость, неконтролируемые вспышки гнева и раздражения. Это происходит от того, что пациенты, узнав о диагнозе, мобилизируют все свои силы на борьбу с болезнью, откладывая душевные переживания «на потом». И когда длительное лечение подходит к концу, эмоции, долгое время сдерживаемые, прорываются вовне. Психолог поможет пережить эти сложные и мучительные чувства, чтобы женщина могла полноценно жить дальше. Ведь жизнь – это то, что происходит сейчас, а не когда-то, когда будет подходящий момент для решения [6].

Сегодня в арсенале психологов имеется огромное количество высокоэффективных методик, которые являются усиливающими, вспомогательными, поддерживающими средствами для основного лечения и реабилитации женщин, больных раком груди (рисунок 3).



Рисунок 3 - Арт-терапия в сенсорной комнате с пациентами после мастэктомии

Есть основные психотерапевтические задачи, решаемые в рамках программы помощи онкопациентам:

- Работа с конкретным симптомом – боль, тошнота, страхи и т.д.
- Работа с темой здоровья и болезни (в целом), направленная на стимулирование у пациента процесса принятия болезни и здоровья, как важных аспектов жизни.
- Работа с мифами рака.
- Коррекция алекситимии.

- Работа с ранними травматическими темами (к источнику проблемы) – обидами, стрессовыми переживаниями.
- Работа с базовой проблематикой – доверие, границы, креативность, сексуальность и т.д.
- Работа с семейными онкологическими сценариями.
- Работа с экзистенциальными переживаниями (темы – «жизнь», «смерть», «жизненный путь», «смыслы жизни», «достижение мудрости»).
- Структурирование и планирование будущего.

В каждом случае лечение всегда индивидуально, не является исключением и психологическая помощь. Но основа выздоровления у всех одинаковая – это не пассивное ожидание излечения, а активная, совместно с врачами, психологами, социальными работниками – борьба за свое здоровье [7].

Таким образом, реабилитация онкологических больных при функционально-щадящем и комплексном лечении – многоэтапный процесс, восстановительный по сути и содержащий несколько важнейших компонентов – реконструктивно-пластический, ортопедический, социально-трудовой. Процесс реабилитации должен носить непрерывный характер. Только так можно добиться успеха в восстановлении участия онкологического больного в активной жизни.

Список литературы

1. Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В. О психогенных реакциях у онкологических больных // Журнал невропатологии и психиатрии.
2. Бронников В.А. и др. Справочник по комплексной реабилитации инвалидов. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2010.
3. Карякина О.И., Карякина Т.Н.. Основы реабилитации инвалидов: Учебное пособие. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 1999. – 88 с.
4. Колмогоров И.А. Актуальные вопросы профилактики, диагностики, терапии и реабилитации психических расстройств // Сборник статей. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2014.
5. Куртанова Ю.Е., Щербакова А.М. Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья // Мат. международной научно-практической конф. – М.: МГППУ, 2011.
6. Януц Н.П. Особенности психотерапевтической работы с женщинами после мастэктомии. Материалы тезисов съезда 2009 г. ассоциации онкопсихологов <http://www.oncopsychology.ru/ru/congress-abstracts-2009/26-2010-06-21-19-23-47.html>
7. Хусаинова И.Р., Исхакова Э.В., Пахратдинова Б.У. и др. Психолого-социальная помощь в онкологической службе // Руководство. – Алматы, 2016. – С.74-80.

ТҰЖЫРЫМ**Ж.Ф.Айуп, Г.А.Рысбаева**

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

**Сут безінің қатерлі ісік барысында мастектомиядан кейін
психоого- әлеуметтік оналту**

Мақалада мастектомия жасалған әйелдердің реабилитациясы қарастырылады. Сонымен қатар реабилитацияның түрлері және олардың адам денсаулығы үшін маңызы баяндалады. Тағы қатерлі ісікке шалдыққан адамдарды, еңбек әрекетіне шамаларына қарай толық немесе жартылай қайтару туралы мәселелер көтеріледі.

Түйінді сөздер: реабилитация, мастектомия, психоәлеуметтік қолдау, эмоционалды тепе-теңдік, тән қызметін белсендіру, мамандық таңдауда ақыл-кеңес жүргізу, әлеуметтік бейімделу, әлеуметтік-тұрмыстық реабилитация; реабилитацияның превентивті түрі, бекітетін түрі, қолдайтын түрі, паллиативті түрі.

SUMMARY**J.G.. Ayup, G.A. Rysbaeva**

Kazakh Institute of Oncology and Radiology

Psychosocial rehabilitation after mastectomy in breast cancer

Rehabilitation of women who made a mastectomy will be considered in the article. There will be a report about the types of rehabilitation and their importance for human's health. And it will be discussed about the returning of people suffering from cancer for a full or partial employment, depending on their conditions.

Keywords: rehabilitation, mastectomy, psychosocial support, emotional balance, activation of body's work, advice in profession choosing, social adaptation, social rehabilitation, preventive type of rehabilitation, approving type, supporting type, palliative type.